リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年10月16日（金）

第36号　朝刊

きょうの紙面　▶回復期・退院後　▶嚥下・ST　▶上肢・OT　▶短信 10本

■ 回復期・退院後

回復期退院後の体調感はFIMと無関係 運動習慣・他者交流・生活範囲が関連

森之宮病院の退院後質問紙調査、1か月は転倒・6か月は余暇活動も関連

森之宮病院の回復期リハ病棟を2020年10月～24年12月に自宅退院した脳卒中患者のうち、同意した774名に、退院後1か月と6か月の「体調」（主観的健康感、4段階）を尋ねた。解析できたのは1か月時点227名、6か月時点109名で、年齢中央値は59歳。

順序ロジスティック回帰で、両時点とも体調の良さと関連したのは運動習慣（オッズ比4.84、4.01）、他者交流（2.84、3.00）、生活範囲を測るLSA（いずれも1.03）だった。退院時のFMA、MMSE、FIMなどのスコアは、どちらの時点でも独立した関連を示さなかった。1か月時点では転倒（1.63）、6か月時点では趣味・余暇活動（2.71）も加わった。

著者は、移行期は転倒予防、安定期は余暇活動の再構築という段階的な支援を提案する。ただし回収率は1か月34.4%、6か月16.9%と低く、健康意識の高い人が答えた偏りは否定できない。関連であって因果ではない。



退院時の機能より、運動・交流・生活範囲。回収率は低い。

出典 作業療法 45巻5号 ↗

数字で見る

774名
調査に同意した自宅退院者

4.84倍
運動習慣の1か月時点OR

34.4%
1か月時点の回収率

■ 嚥下・ST

脳卒中後の嚥下リハ、ゲーム化でFOIS平均1.53点高いが異質性は極めて高い

RCT 7件・340人を統合した。主要評価のFOIS（経口摂取の尺度）はゲーム化群で平均1.53点高く（95%CI 0.58～2.49）、4件で見た簡易嚥下評価SSAも2.44点低かった（改善側）。

ただしFOISの異質性はI^2=96%で、1件を除いても1.04点、I^2=85%のまま。偏りリスクの高い研究を含み、複数の介入が混在してゲーム化単独の効果は切り分けにくい。部分群は探索的で、効果量はそのまま当てはめない方がよい。



出典 Dysphagia ↗

■ 上肢・OT

慢性期脳卒中の手、電気刺激2種でARATが約12点改善　両者に差なし

発症6～18か月の45～65歳60人を感覚電気刺激（SES）、筋電誘発の交互刺激（Alt-EMG）、対照に各20人で割り付け、全員が通常のPTを12週受けた。対照との調整後ARAT差はSESで12.05点、Alt-EMGで12.44点（いずれもP<.001）で、両刺激に差はなかった。

痙縮と筋力も、指伸筋を除き多くの項目で刺激群が上だった。各群20人と小規模で抄録に追跡の記載はなく、効果の持続は不明。



出典 NeuroRehabilitation ↗

短信

〈心リハ〉 **CABG後、在宅テレリハとセンター型は同等**
CABG後111人のRCT。peak VO2は+5.1と+4.8、6分間歩行は+85.2mと+81.5m。 出典 J Cardiopulm Rehabil Prev ↗

〈制度〉 **通所リハのリハマネ、目標設定を明確化案**
介護給付費分科会（10/14）の案。生活行為向上リハ加算の算定率は利用者ベースで0.1%にとどまる。
出典 PT-OT-ST.NET ↗

〈評価〉 **心リハ終了時のPhAが再入院を予測**
83人の後ろ向き。中央615日で25.3%が再入院し、終了時PhAの調整ハザード比0.49。 出典 Prog Rehabil Med ↗

〈嚥下〉 **FEESの手順は施設でばらつき大**
FEES経験者97人の調査。PASの使用は98.9%、感覚検査や色素の使い方はばらついた。 出典 Dysphagia ↗

〈OT〉 **運転関連の認知検査、脳梗塞204人で2因子**
運転再開を望む204人。TMT-J等の結果は視空間・構成と注意・処理速度の2因子で、相関r=0.78。 出典 作業療法 ↗

〈運動器〉 **肥満管理で歩行速度0.77→0.91m/s**
セマグルチド併用の多職種12か月プログラム。22人の後ろ向き観察で、体重は89.2→81.5kg。 出典 Intern Med ↗

〈職場〉 **キャリアパスを有益と感じる群は職場評価が高い**
北見の2病院のリハ職37人（有益群23、非有益群14）。同時点の関連で因果は言えない。 出典 理学療法学 ↗

〈心大血管〉 **HeartMate 3、日本登録で複合イベント9%**
J-MACS登録978人。2年の複合イベントは9%対23%（HeartMate II）、生存率は差なし。 出典 Circ J ↗

〈肩〉 **脳卒中の肩、肩峰-上腕骨頭距離の左右差で3群**
脳卒中47人の探索的検討。左右差の正値群は疼痛が強く、上肢機能が低かった。 出典 理学療法学 ↗

〈股関節〉 **女性THA、サルコペニアリスクと下腿周径の変化**
術前から退院時の下腿周径の変化は、サルコペニアリスク該当と関連。浮腫等の影響を示唆。 出典 総合理学療法学 ↗